

CAPÍTULO 13.8

Síndrome bronquial obstructivo recurrente

PERFIL EUNACOM 1.13.08

Dx: Específico • Tx: Completo • Seg: Completo

El **Coqueluche**, también conocido como **tos ferina** o **tos compulsiva**, es una enfermedad infectocontagiosa inmunoprevenible incluida en el **Plan Nacional de Inmunizaciones** (PNI). A pesar de la vacunación, persisten casos anuales y brotes cíclicos. Su gravedad es inversamente proporcional a la edad, siendo especialmente severa en **lactantes menores de 3 meses** y personas no vacunadas.

Etiología y Definiciones

La causa principal es la bacteria gramnegativa **Bordetella pertussis**.

- **Agentes causales:** Principalmente *B. pertussis*, pero también *B. parapertussis* y otras especies menos frecuentes.
- **Síndrome Coqueluchoideo:** Cuadro clínico similar al coqueluche pero causado por otros agentes como:
 - **Mycoplasma**
 - Adenovirus
 - Virus Respiratorio Sincicial (VRS)
 - Aspiración de cuerpo extraño

NOTA CLÍNICA

El término "Coqueluche" se reserva específicamente para el síndrome clínico causado por bacterias del género *Bordetella*.

Cuadro Clínico

La enfermedad se desarrolla en tres etapas clásicas. Su duración total puede ser de varios meses (la "tos de los 100 días").

TABLA 13.8.1: FASE VS DURACIÓN

FASE	DURACIÓN	CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS
Catarral	1 - 2 semanas	Cuadro indistinguible de un resfriado común. Rinorrea acuosa (no purulenta) y ausencia de fiebre .
Paroxística	2 - 8 semanas	Tos quintosa, accesos de tos, "gallito" inspiratorio, emesis post-tusiva.
Convalecencia	Semanas a meses	Disminución gradual de la frecuencia e intensidad de la tos.

Características de la Fase Paroxística

Es la etapa más característica y donde se realizan la mayoría de los diagnósticos: - **Tos Quintosa:** Accesos de tos bruscos (al menos 5 golpes de tos seguidos) que impiden la respiración. - **Gallito Inspiratorio:** Estridor inspiratorio al final del acceso de tos. - **Signos asociados:** Petequias en la cara (por esfuerzo), hemorragias subconjuntivales. - **Tos Emetizante:** Tos que provoca el vómito (muy sugerente de coqueluche en adultos y niños).

ADVERTENCIA Y PRECAUCIÓN

En **lactantes pequeños** (menores de 3 meses) o niños no vacunados, el coqueluche puede presentarse únicamente como **apneas respiratorias**. Toda apnea sin causa clara en un lactante debe hacer sospechar coqueluche.

Diagnóstico

El diagnóstico es fundamentalmente clínico, pero requiere confirmación microbiológica.

- **PCR (Reacción en Cadena de la Polimerasa):** Es la técnica de elección actual por su alta sensibilidad y rapidez. Ha desplazado a la inmunofluorescencia directa (IFD).
- **Cultivo:** Se realiza en medios especiales (Bordet-Gengou). Es muy específico pero poco sensible, ya que *Bordetella* es una bacteria

"fastidiosa" que muere fácilmente durante el transporte.

- **Serología (IgG contra toxina pertussis):** Útil para diagnóstico retrospectivo en pacientes que llevan más de 4 semanas con síntomas, cuando la PCR y el cultivo suelen ser negativos.
- **Hemograma:** Es muy característico encontrar una **linfocitosis absoluta** importante. Puede llegar a niveles de **reacción leucemoide** (>50.000 linfocitos/mm³).
- **Radiografía de Tórax:** Suele ser normal o mostrar infiltrados inespecíficos. Se solicita principalmente para descartar complicaciones (neumonía) o diagnósticos diferenciales (cuerpo extraño).

PERLA CLÍNICA EUNACOM

Ante un lactante con sospecha de coqueluche, siempre se debe interrogar por **contactos con tos** en el hogar. La vacuna protege contra la enfermedad grave, pero los adultos vacunados pueden tener cuadros leves de tos prolongada y contagiar al lactante.

Tratamiento

El tratamiento de elección son los **macrólidos**. El objetivo principal es acortar el periodo de contagio y, si se inicia precozmente, disminuir la duración de los síntomas.

Esquemas Antibióticos

1. **Azitromicina (Elección):** - Dosis: **10 mg/kg/día** (máximo 500 mg) por **5 días**. - Ventaja: Dosificación sencilla y mejor tolerancia. 2. **Claritromicina:** Por 10 a 14 días. 3. **Eritromicina:** Por 10 a 14 días. 4. **Cotrimoxazol:** Alternativa en caso de alergia o intolerancia a macrólidos.

EUNACOM CRITERIOS

El tratamiento antibiótico es más efectivo cuando se inicia en la **fase catarral**. Si se inicia después de **21 días** de síntomas, la evidencia muestra que ya no altera el curso de la enfermedad ni disminuye el contagio, aunque en niños y pacientes de riesgo se suele indicar de todas formas.

Manejo y Complicaciones

- **Hospitalización:** Recomendada en lactantes menores de 3-6 meses, pacientes con apneas, cianosis o dificultad respiratoria severa. - **Antitusígenos:** No han demostrado utilidad y no se recomiendan de rutina. - **Complicaciones:** - Neumonía (causa principal de muerte). - Encefalopatía y convulsiones (por hipoxia o toxina). - Desnutrición o deshidratación por vómitos repetidos.

NOTA CLÍNICA

La fisiopatología de las convulsiones en el coqueluche es multifactorial, involucrando hipoxia durante los paroxismos, microhemorragias cerebrales y los efectos de la toxina pertussis en el sistema nervioso central.

Manejo de Contactos

El coqueluche requiere el manejo de los contactos cercanos para cortar la cadena de transmisión. Esto incluye profilaxis antibiótica (generalmente con azitromicina) independientemente del estado vacunal, especialmente si hay lactantes o embarazadas en el grupo de contacto.

Prevención y Profilaxis: Coqueluche

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM**ESCENARIO CLÍNICO TÍPICO:**

"Lactante de 16 meses con antecedente de bronquiolitis por VRS a los 3 meses y 3 episodios adicionales de sibilancias en los últimos 8 meses. Actualmente asintomático. ¿Cuál es el manejo de mantención más adecuado?"

EXPLICACIÓN CLÍNICA DETALLADA:

Manejo clínico y diagnóstico según normativa MINSAL y perfil EUNACOM para Síndrome bronquial obstructivo recurrente. Priorizar reconocimiento precoz y tratamiento de primera línea.

PUNTOS CLAVE DESTACADOS

- SBOR se define como 3 o más episodios de SBO en un lactante; el diagnóstico es clínico
- La causa es hiperreactividad bronquial posviral (post-VRS), a diferencia del asma que es por alergia
- El manejo cambia respecto al SBO agudo: se agrega corticoides inhalados cada 12 horas
- Salbutamol SOS (2 puffs) se mantiene para crisis agudas
- Dosis alta de corticoides inhalados durante crisis; dosis baja en periodos asintomáticos
- Montelukast puede agregarse, aunque sirve más en asma que en SBOR
- Toda SBOR requiere radiografía de tórax para descartar causas secundarias
- El manejo del SBOR es similar al del asma

EVALUACIÓN DE CLASE Y PREGUNTAS TIPO EUNACOM (SÍNDROME BRONQUIAL OBSTRUCTIVO RECURRENTE)**PREGUNTA 1**

Lactante de 16 meses con antecedente de bronquiolitis por VRS a los 3 meses y 3 episodios adicionales de sibilancias en los últimos 8 meses. Actualmente asintomático. ¿Cuál es el manejo de mantención más adecuado?

- A)** Salbutamol 2 puffs cada 8 horas de forma fija
- B)** Corticoides inhalados cada 12 horas más salbutamol SOS
- C)** Solo salbutamol SOS, sin tratamiento de mantención
- D)** Corticoides sistémicos orales diarios por 3 meses
- E)** Antibióticos profilácticos para prevenir infecciones virales

PREGUNTA 2

¿Cuál es la principal diferencia fisiopatológica entre el SBOR y el asma?

- A)** El SBOR es causado por hiperreactividad bronquial posviral; el asma por hiperreactividad alérgica
- B)** El SBOR solo ocurre en mayores de 2 años; el asma en menores de 2 años
- C)** El SBOR no responde a broncodilatadores; el asma sí
- D)** El SBOR es causado por bacterias; el asma por virus
- E)** No hay diferencia fisiopatológica; son la misma enfermedad

PREGUNTA 3

Lactante de 18 meses diagnosticado con SBOR consulta por nuevo cuadro de infección respiratoria alta y sibilancias leves. Se encuentra en tratamiento con corticoides inhalados 1 puff diario. ¿Cuál es la conducta más adecuada respecto a sus corticoides inhalados?

- A)** Suspender los corticoides inhalados y dejar solo salbutamol
- B)** Mantener la misma dosis de 1 puff diario
- C)** Aumentar a 2 puffs diarios (1 cada 12 horas) durante la infección
- D)** Cambiar a corticoides orales y suspender los inhalados
- E)** Agregar antibióticos sin modificar los corticoides

RESUMEN: SÍNDROME BRONQUIAL OBSTRUCTIVO RECURRENTE

El síndrome bronquial obstructivo recurrente (SBOR) se define como 3 o más episodios de SBO en un lactante. Su importancia radica en que el manejo cambia respecto al SBO agudo aislado, volviéndose similar al manejo del asma. La causa habitual es una hiperreactividad bronquial posviral, secundaria a una infección inicial por virus respiratorio sincicial (VRS), a diferencia del asma donde la hiperreactividad es secundaria a alergia. El mecanismo fisiopatológico consiste en que el lactante se infecta inicialmente con VRS, hace una bronquiolitis, y posteriormente, ante cualquier nueva infección viral (rinovirus, parainfluenza, etc.), desarrolla nuevas crisis obstructivas por la hiperreactividad bronquial residual. El diagnóstico es absolutamente clínico: tres o más crisis obstructivas documentadas. El manejo del SBOR incluye salbutamol SOS (2 puffs ante síntomas) más corticoides inhalados cada 12 horas como tratamiento de mantención. En el SBO no recurrente los corticoides inhalados no se indicaban; ahora son parte fundamental del tratamiento. La dosis se ajusta según el estado clínico: dosis más alta (2 puffs del corticoide al día) durante crisis o infecciones respiratorias, y dosis más baja (1 puff al día) en periodos libres de síntomas. Eventualmente puede agregarse montelukast, aunque su beneficio es mayor en asma que en SBOR. Como parte del estudio, todo SBOR debe tener una radiografía de tórax, no para el diagnóstico (que es clínico), sino para buscar causas secundarias del cuadro obstructivo recurrente o complicaciones asociadas.